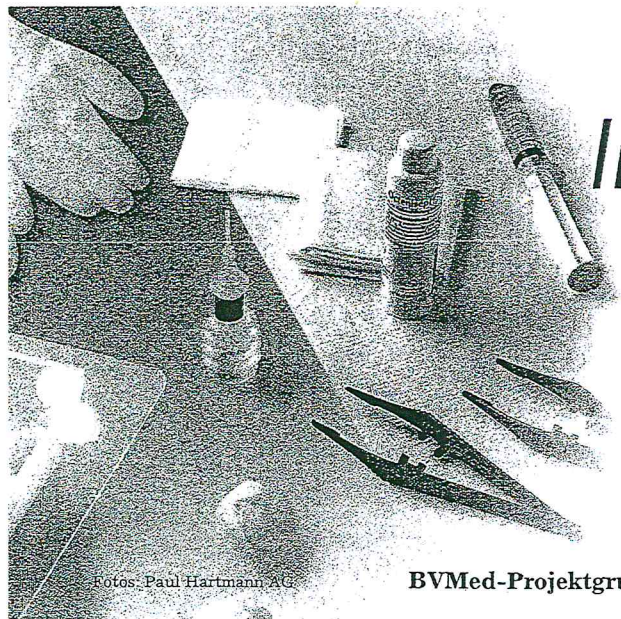


Qualitätsorientierte Versorgung

Bedeutung und Einsatz der ableitenden Inkontinenzversorgung



Fotos: Paul Hartmann AG

BVMed-Projektgruppe

Versorgungssets zur Katheterisierung in der stationären und ambulanten Pflege

Harninkontinenz ist eine der häufigsten Alterserkrankungen und ist verbunden mit körperlichen Beeinträchtigungen, psychosozialen Problemen und ökonomischen Kosten. Diese Belastungen für den Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft beinhalten erhebliche „Kosten“, die bisher viel zu wenig untersucht und dargestellt wurden. In den nächsten Jahren muss – auch aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung – mit über 100 Millionen Inkontinenten weltweit gerechnet werden. Medizinische und soziale Probleme dieser Patienten sowie die hohen Kosten, die durch unzureichend therapierte Inkontinenz entstehen, begründen die Notwendigkeit für eine qualitätsorientierte Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln.

In Deutschland kostet die Pflege inkontinenter Menschen jährlich etwa 1 Milliarde Euro, weitere 1 Milliarde Euro fließen in die ambulante Versorgung und Therapie. Harninkontinenz tritt abhängig vom Alter bei sieben bis 21 Prozent der Frauen und bei zwei bis drei Prozent der Männer auf. In Deutschland werden derzeit etwa 75 Prozent der Inkontinenten zu Hause versorgt, 25 Prozent leben in Heimen. In Altenheimen sind ein bis zwei Drittel der Bewohner betroffen. Sie betrifft in Deutschland rund fünf Millionen Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Harn und/oder Stuhlabgang bewusst zu kontrollieren. Die Betroffenen stehen nicht nur in der Gefahr ihrer sozialen Isolation. Vor allem schwerwiegende Komplikationen wie re-

zidivierende Harnwegsinfektionen, Harnstauungen, terminale Niereninsuffizienz, Dekubitalulzera usw. sind die Folge.

Harnwegsinfektionen zählen mit nahezu 40 Prozent zu den häufigsten nosokomialen Infektionen. Bis zu 90 Prozent werden ursächlich mit einem Kathetersatz, weitere zehn Prozent mit einem urologisch-endoskopischen Eingriff assoziiert. Die wichtigsten Risikofaktoren sind:

- Dauer der Katheterisierung
- Diabetes mellitus
- Weiblicher Patient
- Andere Indikationen als operativer Eingriff oder Messung der Urinausscheidung
- Erhöhtes Serumkreatinin
- Fehler in der Katheterpflege
- Periurethrale Kolonisation mit potenziell uropathogenen Keimen

periurethral = um die Harnröhre

Tab. 1 Patienten in Deutschland mit Harninkontinenz
(Häufigkeit in Prozent)

Alter	Frauen	Männer
unter 65 Jahren	1,1 Mio. – 5,0 %	0,2 Mio. – 1,0 %
über 65 Jahren	1,5 Mio. – 14,7 %	0,5 Mio. – 8,0 %
zusammen	2,6 Mio. – 19,7 %	0,7 Mio. – 9,0 %

Quelle: Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V.,
Qualitätsmanual Mikrostörungen & Harninkontinenz, 2000

- Mikrobielle Kolonisation des Auffangbeutels
- Mangelnde Erfahrung des Katheterisierenden
- Unsystematische Arbeitsabläufe.

Diesen Risiken kann neben einer strengen Indikationsstellung vor allem durch qualifizierte aseptische Anwendungstechnik nach RKI-Richtlinien begegnet werden. Gewährleistet wird dies durch einen aseptischen sowie systematischen Arbeitsablauf. Die Anwendung von Versorgungssets ist hierfür notwendig.

Gezielte therapeutische Maßnahmen zur Vermeidung lebensbedrohender Komplikationen am Harntrakt sind unverzichtbar. Dazu gehört die Anwendung beispielsweise von Versorgungssets oder die Applikation eines Dauerkatheters. Die einschlägigen ärztlichen Behandlungsrichtlinien geben hier die Verwendung von Kathetersets vor. Allerdings fehlt bislang im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung eine einschlägige Regelung zur Kostenübernahme.

Was sind Versorgungssets?

Basisinhalte eines Versorgungssets, nach den RKI Richtlinien, sollten sein: steriles Einschlagstuch, geschlitztes Lochtuch, Tupfer, Kompressen, Pinzetten, Urinauffangbehältnis. Die Sets sind mit oder ohne Katheter erhältlich. Sie sind jeweils nach einer Systematik aufgebaut und damit gerade bei der Katheterisierung einfach und sicher zu handhaben. Rüstzeiten für die einzelnen Materialien entfallen. Die Zusammensetzung ist auf die individuelle Versorgungssituation des Patienten abzustimmen.

Grundlagen zur pflegerischen Versorgung

Der Einsatz von Hilfsmitteln nimmt im Rahmen der Versorgung von Menschen mit Blasen-

Ableitende Inkontinenzversorgung ist zum Beispiel erforderlich bei:

- Querschnittlähmung
- Spina bifida
- Multipler Sklerose
- Schädel-Hirnverletzungen
- Wirbelsäulentumore
- Bandscheibenvorfall
- Hirntumore
- Neuropathien unterschiedlicher Genese
- Störung der Blasenfunktion infolge von Intoxikationen
- Apoplexie
- Diabetes mellitus
- Morbus Alzheimer

Postoperative Dysfunktionen

Nach Anlage von Darmersatzblasen

Obstruktionen des Harntraktes unterschiedlicher Genese

Erkrankungen mit hoher Restharnbildung

Palliative Behandlung der Inkontinenz (selten)

Instillation in die Blase zur Therapie der Detrusorhyperaktivität

Instillation in die Blase im Rahmen einer Chemotherapie

Tab. 2

funktionsstörungen eine zentrale Rolle ein. Hilfsmittel im Rahmen des Managements von Blasenfunktionsstörungen werden unter folgenden Aspekten eingesetzt:

■ als Hilfsmittel zur Therapie der neurogenen Blasenfunktionsstörung mit dem Ziel der Vermeidung von Inkontinenz, Sekundärveränderungen des Harntraktes und Infektionsprophylaxe,

■ als Hilfsmittel zur palliativen Versorgung der Inkontinenz, bei Versagen aller zur Verfügung stehenden sinnvollen therapeutischen Optionen, mit dem Ziel der Vermeidung von Hautschädigungen, Niereninsuffizienz,

■ Hilfsmittel als unterstützende Maßnahme einer begonnenen Therapie.

Die eingesetzten Hilfsmittel müssen bei der Auswahl der Form der Blasenfunktionsstörung Rechnung tragen. Hilfsmittel für den intermittierenden Katheterismus müssen eine aseptische und atraumatische Katheterisierung an jedem möglichen Ort zulassen. Harndauerableitungen müssen so konzipiert sein, dass einer Traumatisierung des Harntraktes weitestgehend präventiv begegnet werden kann. Der individuell

gewählte Zugangsweg (transurethral oder suprapubisch) muss sich hierbei an der Diagnose orientieren. Die Auswahl der verwendeten Kathetermaterialien wird durch die voraussichtliche Liegedauer bestimmt.

Der Katheterismus der Harnblase stellt einen minimal invasiven Eingriff dar. Grundsätzlich besteht die Gefahr der Keimverschleppung ins Blaseninnere. Angelehnt an die Bedingungen eines operativen chirurgischen Eingriffs, ist die Schaffung steriler Arbeitsbedingungen zu fordern. Da Katheteranlagen, Katheterwechsel bzw. der intermittierende Einmalkatheterismus nicht in speziell desinfizierten Operationsräumen durchgeführt werden, ist ein standardisiertes Arbeitsmaterial, das optimale Bedingungen außerhalb von Clean-Arbeitsräumen schafft, eine unausweichliche Grundanforderung. Versorgungssets schaffen die Bedingungen für die Erfüllung des Anspruchs absoluter Asepsis beim Katheterisieren.

Im Rahmen der Sicherstellung des aseptischen Vorgehens wurden durch die CDC 1997 zur Prävention katheterassoziierter Harnwegsinfektionen folgende Empfehlungen fixiert:

„Kategorie I:

- aseptisches und atraumatisches Katheterisieren durch geschultes Personal
- strenge Indikationsstellung für Blasenkathester
- Händedesinfektion vor und nach der Manipulation am Katheter oder Drainagesystem
- aseptische Katheterisierung mit einem sterilen Katheterisierungsset
- ...“ (1).

Der Basisinhalt eines Kathetersets sollte folgende Materialien enthalten:

- ein steriles Einschlagtuch als sterile Arbeitsunterlage,
- ein Lochtuch, geschlitzt, zur Abdeckung des Genitalbereiches,
- vier Tupfer und zwei Kompressen zur Desinfektion der Genitalien,
- zwei Pinzetten, eine für die Desinfektion und eine zum Einführen des Katheters,
- ein Urinauffangbehälter,
- eine Außenschale zum Abwerfen des gebrauchten Materials,
- ein Paar sterile Handschuhe (2).

unter den Wohnungsbedingungen gewechselt werden muss. Ein standardisiertes Versorgungsset sorgt für die Schaffung der minimalen hygienischen Grundanforderungen.

Stellt das Versorgungsset neben dem Katheter einen weiteren Kostenblock für die Krankenversicherer dar, darf es aber nicht darüber hinweg täuschen, dass mit dieser Versorgungsoption, gerade im ambulanten Bereich, eine Kostenentlastung verbunden ist. Erhebliche Zusatzkosten entstehen den Krankenversicherungen in dem Augenblick, wo der Patient zur Neuanlage oder dem Wechsel des Ableitungssystems eine klinische Einrichtung aufsuchen muss.

In einer Untersuchung zur urologischen Notfallversorgung katheterisierter Patienten im Raum Herne von Januar bis Juni 2001 stellten sich 81 Patienten aus Alten- und Pflegeheimen notfallmäßig in der urologischen Notfallambulanz zur Versorgung von Komplikationen des Ableitungssystems vor. Die Summe der verursachten

Ursache für die Versorgungsverlagerung war nicht ausreichend qualifiziertes Personal oder fehlendes Arbeitsmaterial (3).

Bedenkt man in diesem Zusammenhang, dass durch das Fehlen eines Versorgungssets die ambulant zu erbringende Leistung in den stationären Bereich verlagert werden müsste, würden allein durch den Patienten-transport erhebliche Kosten verursacht.

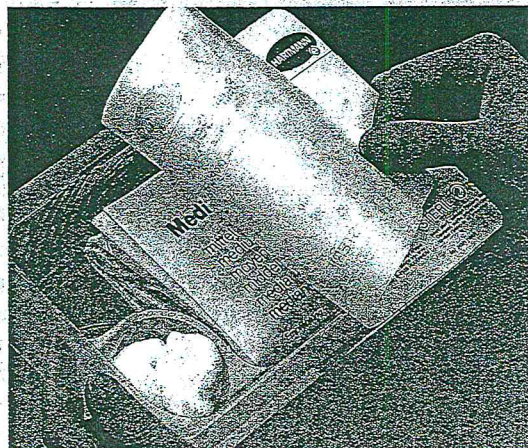
Fazit aus pflegerischer Sicht

Im ambulanten und stationären Bereich ist das Vorhandensein eines Versorgungssets ein entscheidender Sicherheits- und Qualitätsaspekt. Ein aseptisches Instrumentieren wird hiermit ermöglicht. Betrachtet man die einzelnen Bestandteile eines Versorgungssets, so gehören sie vordergründig nicht zur „Grundausstattung“ eines Alten- und Pflegeheimes.

Die Einzelbeschaffung der erforderlichen Komponenten bedeutet im Gegensatz zur Set-Lösung eine Ausweitung des Erstattungsprozedere, da unterschiedliche Kostenstellen der Krankenkassen in die Versorgung integriert werden müssten. Eine aseptische Katheterisierung ist mit individuell zusammengestellten Einzelteilen gerade in der ambulanten Versorgung skeptisch zu hinterfragen (4).

Die Bereitstellung eines Versorgungssets aus pflegerischer Sicht hat mehrere Vorteile:

1. Das Versorgungsset garantiert, dass alle benötigten Materialien kompakt zur Verfügung stehen. Ein mühseliges Zusammensuchen entfällt. Dieser Aspekt erlangt besonders in urologischen Notfallsituationen besondere Bedeutung, da mit der Versorgung des Betroffenen unverzüglich begonnen werden kann.
2. In Kliniken und Alten- und Pflegeheimbereich wird weiter-



Das MediSet-Katheter-Set von Hartmann

Grundsätzlich sind zwischen transurethaler und suprapubischer Dauerableitung und intermittierenden Selbst- und Fremdkatheterismus Spezifizierungen erforderlich. Ein Großteil Menschen benötigt eine Harndauerableitung, die

Transportkosten belief sich auf 15 450 Euro exklusive der erbrachten medizinischen Leistung. Im Resümee der Untersuchung wird festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Versorgung im Pflegeheim hätte durchgeführt werden kön-

hin der Lagerbedarf reduziert. Nicht erforderliche Rüstzeiten des benötigten Materials ermöglichen den qualifikationsgerechten Einsatz der Pflegekraft.

3. In der ambulanten Patientenversorgung ist das Material kompakt und einsatzbereit vorhanden. Hygienische Anforderungen können im außerklinischen Bereich durchgesetzt werden.

Die Bereitstellung eines Versorgungssets zur Blasenkatheterisierung schafft für Pflegenden juristisch eindeutige Bedingungen. Da der Katheterismus einen invasiven Eingriff darstellt, bedarf er immer einer ärztlichen Anordnung. Dem Arzt obliegt damit die Anordnungsverantwortung.

Das Einbringen eines transurethralen Katheters ist an die Pflegekraft delegierbar. In diesem Augenblick greift die Durchführungsverantwortung. Die Pflegekraft ist für den fachgerechten Einsatz des Materials mit dem Ziel der Vermeidung von Schädigungen des Patienten verantwortlich. Das Versorgungsset schafft durch seine geprüften und zugelassenen Materialien die entsprechende Versorgungssicherheit auf Medizinprodukte-seite.

Wirtschaftliche Bedeutung

Neben der Form der Inkontinenzversorgung dürfte auch die Qualität des jeweiligen Inkontinenzhilfsmittels beim Thema Wirtschaftlichkeit und Kosten eine entscheidende Rolle spielen.

Direkte und indirekte Kosten

Durch die Erkrankung Inkontinenz entstehen, neben hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten, erhebliche pflegerische, medizinische Kosten, die sich in direkte und indirekte Kosten unterscheiden lassen (Tab. 3).

Gesamtwirtschaftliche Kosten

Unsachgemäße Anwendung und unzureichende Hygiene können

Beispiele für direkte Kosten

Pflegerischer Aufwand in Pflegeminuten
Medizinischer Aufwand in Arziminuten
Kosten für Hilfsmittel und medizinischer Sachbedarf
Harnwegsinfekte
Harnwegsdefekte
Urosepsis

Beispiele für indirekte Kosten

- Medikamenteninteraktionen
- Allergien
- Sekundärinfektionen
- Arbeitsunfähigkeit

Tab. 3

zu Infektionen und Folgeerkrankungen führen. Die dadurch entstehenden Folgekosten haben hohe gesamtwirtschaftliche Relevanz. Mit Hilfe von standardisierten Versorgungssets können solche Kosten völlig vermieden oder wenigstens weitgehend gesenkt werden. Hier resultieren oftmals aus den Folgeerkrankungen Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausaufenthalte, die nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen und Sozialversicherungsträger belasten, sondern die gesamte Gesellschaft.

Versorgungssets: Wirtschaftlichkeit gegenüber Einzelkomponenten

Versorgungssets sind gegenüber Einzelkomponenten besonders wirtschaftlich. Die Ablehnung der Kostenübernahme für Versorgungssets wird oftmals mit Verweis auf die Wirtschaftlichkeit und fehlende Begründung zur Notwendigkeit der Verwendung einzelner Komponenten des Sets geführt. Die Betrachtung der gesamten Behandlungskosten belegt allerdings, dass der Einsatz von Sets gegenüber der Verwendung von Einzelkomponenten weitaus kostengünstiger ist.

Um Folgekosten in der ableitenden Inkontinenzversorgung

zu senken, gilt es neben der Prävention und der Vermeidung von primären und sekundären Infektionen standardisierte Verfahren mit Sets zum Katheterisieren einzusetzen. Versorgungssets sind aus hygienischer Sicht von großem Interesse, werden aber wegen ihrer angeblich hohen Kosten und der unklaren Erstattungsmodalität im ambulanten Sektor in Frage gestellt. Im stationären Bereich gehören sie zum Standard und fallen in die Kosten des medizinischen Sachbedarfs.

Ableitende Inkontinenzversorgung in der GKV

Wenn die medizinischen Voraussetzungen für eine Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln bestehen, hat der Patient einen Rechtsanspruch auf Leistung. Grundsätzlich erhält damit der Versicherte das verordnete Hilfsmittel. Für den Arzt ist bei der Verordnung wichtig, dass Inkontinenzhilfen gemäß § 84 Sozialgesetzbuch V nicht in das Arznei- und Heilmittelbudget einfließen. Ähnlich wie bei einigen anderen Hilfsmittelgruppen schränken nun auch im Bereich der aufsaugenden Inkontinenzhilfen bundeseinheitliche Festbeträge diesen Anspruch ein. Für ableitende Inkontinenzhilfen bestehen je nach Krankenkasse und Bundesland in der Höhe unterschiedliche Vertragspreise.

Grundsätzlich werden Kosten für die Hilfsmittel nur zur Höhe dieser Beträge übernommen. Wenn ein höherpreisiges Produkt verordnet wird, muss der Patient den Differenzbetrag zum tatsächlichen Preis selbst bezahlen.

Die separate Abgabe und Kostenübernahme von Einzelprodukten, wie sie bislang von den gesetzlichen Krankenkassen praktiziert wird, gewährleistet demgegenüber nicht die erforderliche Wirtschaftlichkeit, jedoch der Einsatz von Sets. Aus medizinischer und ökonomi-

Anregungen aus der Praxis

schers Sicht besteht im Hinblick auf einheitliche Kostenübernahme ein großer Reformbedarf. Unabhängig von einer kurzfristigen Betrachtung der Kostenseite tragen Versorgungssets zu langfristigen Ressourceneinsparung bei.

Fazit

Bei Betrachtung der Gesamtkosten zeigt sich der Einsatz von Sets gegenüber der Verwendung von Einzelkomponenten überlegen. Bedingt durch die unterschiedlichen Erstattungsmodalitäten lässt sich die Effizienz von Kathetersets nicht in ausschließlich monetären Größen belegen. Unbestritten ist, dass durch Verwendung von Kathetersets die Infektionsraten nachweislich niedriger sind und somit vermeid-

bare Folgekosten durch Infektionen, zusätzlichen Pflegeaufwand und Behandlungskosten in eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung einfließen. Harnableitungsverfahren sind grundsätzlich nicht nur eine Therapieoption für ältere pflegebedürftige Menschen. Über den stationären Pflegebereich hinaus spielt die Harnableitung im ambulanten Bereich, in der Rehabilitation, der gesellschaftlichen Integration sowie in der Infektionsprävention eine wichtige Rolle.

Eine gezielte ableitende Inkontinenzversorgung im ambulanten Bereich kann sogar eine entscheidende therapeutische Option zur Reduzierung oder sogar Vermeidung von Pflegebedürftigkeit darstellen. Sie leistet somit einen wesentlichen

Beitrag zur gesellschaftlichen Reintegration und Rehabilitation von inkontinenten Patienten.

Anmerkungen:

- (1) Vergleiche Prof. Füsgen, „Der katheterassoziierte Harnwegsinfekt“ in „notabene medici“ 3/2003, Seite 109
- (2) Vergleiche Bach/Brühl „Nosokomiale Harnwegsinfektionen“ Jungjohann Verlag 1995
- (3) Die Daten beziehen sich auf einen Vortrag von Dr. Döhring, Herne, auf dem GIH Kongress 2002 (siehe GIH-Referatband 2002, Seite 64 „Sozioökonomische Folgen der Katheterversorgung von Altenheimpatienten“)
- (4) Die Anforderungen zur Prävention katheterassoziierter Harnwegsinfektionen finden sich im Bundesgesetzblatt 42 (1999): 806-809 wieder

Anschrift der Verfasser:

Projektgruppe „Versorgungssets“
des BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e. V.
Reinhardstraße 29 b, 10117 Berlin
Tel. (030) 24 62 55-0
E-Mail: piossek@bvmed.de
Internet: www.bvmed.de

Katheterset

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit

1. Lesen Sie sich den Artikel durch und klären Sie unbekannte Wörter oder Inhalte.
2. Erklären Sie, warum die aufgeführten Risikofaktoren (S. 562/563) eine Harnwegsinfektion beim Kathetereinsatz begünstigen.
3. Begründen Sie warum es in der ambulanten und stationären Pflege sinnvoll ist, ein Versorgungsset / Katheterset beim Blasenkatheterismus zu benutzen.

Wichtig für =
geldlich / die
Finanzen be-
treffend